

· 文献研究 ·

中医药疗法治疗艾滋病合并抑郁症的系统评价与 Meta 分析

许德皓¹ 李静^{2,5} 白鹏³ 张晓雯² 郑佑祥² 江月² 连雅君⁴ 田紫煜² 申晨² 韩梅²
刘建平²

【摘要】 目的 系统评价中医药疗法治疗艾滋病合并抑郁症的疗效与安全性。**方法** 检索包括中国知网、万方数据库、维普数据库、Sinomed、PubMed、Cochrane Library、EMbase、Web of Science 建库以来至 2020 年 2 月收录的有关于中医药疗法治疗艾滋病合并抑郁症的随机对照试验,并对其进行筛选和资料提取。采用 Cochrane 协作网“偏倚风险”评价工具对纳入试验进行方法学质量评价,使用 RevMan 5.3 对研究数据进行合并分析。**结果** 共纳入 6 篇随机对照试验文献,涉及 451 例患者。Meta 分析结果显示,中药方剂联合心理干预较单纯心理疗法明显降低抑郁患者的汉密顿抑郁量表(HAMD)评分($MD -2.06, 95\% CI -3.24, -0.87; Z = 3.4, P < 0.01$);温针灸联合逍遥散较帕罗西汀可显著降低抑郁患者 HAMD 评分($MD -4.68, 95\% CI -6.11, -3.25; Z = 6.41, P < 0.001$)。**结论** 低质量证据显示,使用温针灸联合中药方剂等纯中医疗法,在改善患者抑郁状态、提高患者生活质量方面可能有优势。但由于纳入文献质量不高,该结论需要更多大样本、多中心、高质量的随机对照试验加以验证,为艾滋病合并抑郁症的临床治疗提供更加可靠的证据。

【关键词】 艾滋病;抑郁症;中医;中药;Meta 分析;系统综述

【中图分类号】R512

【文献标识码】A

Traditional Chinese Medicine Therapy for AIDS patients with Depression: a Systematic Review and Meta - Analysis

XU De - hao¹, LI Jing^{2,5}, BAI Peng³, ZHANG Xiao - wen², ZHENG Ruo - xiang², JIANG Yue², LIAN Ya - jun⁴, TIAN Zi - yu², SHEN Chen², HAN Mei², LIU Jian - ping²

(1. Beijing University of Traditional Chinese Medicine, Beijing 100029; 2. Center for Evidence - based Chinese Medicine, Beijing University of Traditional Chinese Medicine, Beijing 100029; 3. The Third Affiliated Hospital of Beijing University of Traditional Chinese Medicine, Beijing 100029; 4. College of Traditional Chinese Medicine, Beijing University of Traditional Chinese Medicine, Beijing 100029; 5. China National Research Institute of Food & Fermentation Industries Co., Ltd, Beijing 100015)

【Abstract】 Objective To evaluate the efficacy and safety of TCM in the treatment of AIDS depression. **Methods** Retrieve databases including CNKI, Wanfang, Vip, SinoMed, PubMed, Cochrane Library, EMBASE, and Web of Science were searched to find the relevant literature on Chinese medicine treatment of AIDS depression. Database searches were up to date as of February 2020. Two authors independently screened trials and extracted data. The Cochrane Collaboration Network "risk of bias" tool was used to assess the risk of bias assessment, and RevMan5.3 was used to analyze the research data. **Results** A total of 6 studies were included in 451 patients. Meta - analysis results showed that Traditional Chinese medicine decoction combined with psychological intervention may reduce the patient's HAMD score ($MD = -2.06, 95\% CI = [-3.24, -0.87]; Z = 3.4, P < 0.01$, two studies). Compared with paroxetine, warming - needle moxibustion combined Xiaoyao San may reduce patients' HAMD score ($MD = -4.68, 95\% CI = [-6.11, -3.25]; Z = 6.41, P < 0.001$). **Conclusion** According to the existing evidence, the use of Chinese medicine such as warming - needle moxibustion combined with traditional Chinese medicine decoction may have advantages in improving the AIDS patients with depression and improving the patient's quality of life. However, because the quality of the evidence is low or very low, the conclusions' certainty is insufficient. It is recommended that more large - sample, multi - center, high - quality randomized

DOI: 10.13935/j.cnki.sjzx.210208

基金项目: 国家自然科学基金面上项目资助(81673828)

作者单位: 1. 北京中医药大学, 北京 100029; 2. 北京中医药大学循证医学中心, 北京 100029; 3. 北京中医药大学第三附属医院, 北京 100029; 4. 北京中医药大学中医学院, 北京 100029; 5. 中国食品发酵工业研究院有限公司, 北京 100015

通信作者: 刘建平, Email: liujp@bucm.edu.cn

controlled trials be carried out to provide more reliable clinical evidence support for this clinical problem.

【Keywords】 AIDS; Depression; Traditional Chinese Medicine; Meta Analysis; Systematic Review

获得性免疫缺陷综合征(Acquired immune deficiency syndrome, AIDS) 又称为艾滋病, 是患者感染人类免疫缺陷病毒(Human immunodeficiency virus, HIV) 引起人体免疫缺陷, 最终导致一系列人体免疫功能缺失的传染性疾病^[1]。联合国艾滋病规划署 2019 年 7 月报告显示, 全球共计 3790 万人感染了艾滋病毒, 其中 80% 以上是在发展中国家^[2]。它不仅造成患者躯体伤害, 同时也在精神心理方面给患者带来严重的创伤, 引起神经精神疾病, 包括抑郁及躯体障碍等。抑郁是在艾滋病患者中最常见的心理症状之一^[3], 估计每 3 个艾滋病毒感染者中就有 1 人经受抑郁的困扰^[4]。虽然药物干预已成为治疗抑郁症的主要手段, 但抗抑郁药对许多人效果不佳^[5]。多药治疗在艾滋病患者中很常见, 增加另一种药物可能会增加药物相互作用和不良事件的发生。因此, 需要安全、有效的替代疗法和非药物治疗手段来缓解病人的抑郁情绪。已有临床试验证明中医药疗法治疗对于改善艾滋病患者抑郁状态有较好疗效, 但缺乏系统性相关汇总分析来形成证据。本研究采用 Meta 分析方法, 评价中医药治疗艾滋病合并抑郁患者的有效性, 从而为临床治疗提供进一步的依据。

1 资料与方法

1.1 检索策略

检索中文数据库包括中国知网、万方数据库、维普数据库、Sinomed。英文数据库包括 PubMed、Cochrane Library、EMbase、Web of Science。检索策略: 中文关键词为“中医、艾滋病、抑郁、随机”, 英文关键词为 HIV, Depression, Complementary therapies, Randomized controlled trial。文献发表年限为各数据库建库以来至 2020 年 2 月。

1.2 文献纳入标准

随机对照试验, 是否使用盲法、发表的语言和类型不作限制; 研究对象为 HIV 感染或艾滋病合并抑郁症患者, 需在文中有明确的 HIV 感染或艾滋病诊断标准及抑郁症诊断标准; 无年龄、性别及种族限制; 中医药疗法包含中药(单味中药、中药制剂、复方汤药或颗粒剂)、针灸、推拿、拔罐等; 对照组为空白、安慰剂、常规西医治疗(抗抑郁药/心理干预); 两组均使用的共同治疗措施如抗病毒治疗也允许纳入。

1.3 结局指标

主要结局指标: 汉密顿抑郁量表(HAMD) 评分; 次要结局指标: 生活质量积分(MOS-HIV、KPS 评分等)、不良事件。

1.4 文献筛选及资料提取

对检索到的文献进行查重, 排除重复研究后, 由两位研究者独立进行文献筛选。研究者通过阅读文献标题、摘要进行第一轮筛选, 后对符合第一轮筛选要求的文献进行全文筛选。两位研究者通过讨论解决分歧, 如无法统一意见, 需第 3 位研究者裁决。两位研究者独立进行资料提取, 无法解决冲突时由第 3 位研究者裁决。利用 Excel 进行资料提取, 提取文献特征、诊断标准、纳入与排除标准、患者基线特征、对照类型、干预措施、疗程、结局测量时间点、结局指标、不良事件、资助来源、利益冲突等。

1.5 文献质量与偏倚评价

采用 Cochrane 协作网“偏倚风险”评价工具^[6], 包括随机序列的生成; 随机隐藏; 患者和工作人员盲法; 结局评价者盲法; 不完整结局数据; 选择性报告结局; 其他偏倚。每 1 项均可被评为“低偏倚风险”“高偏倚风险”或“偏倚风险不确定”。

1.6 统计学方法

应用 RevMan 5.3 软件对数据进行统计分析。对于二分类资料, 采用相对危险度(Risk ratio, RR) 和 95% 置信区间(Confidence interval, CI) 表示; 对于连续性资料, 采用均数差(Mean difference, MD) 和 95% CI 表示。通过 I^2 值判断不同研究间的统计学异质性大小: 当研究间统计学异质性较小时($I^2 \leq 25\%$), 采用固定效应模型进行 Meta 分析; 当研究间存在较大统计学异质性时($25\% < I^2 \leq 75\%$), 采用随机效应模型进行 Meta 分析; 当研究间存在显著统计学异质性时($I^2 > 75\%$), 不进行效应量合并, 只对结果进行定性描述。若数据可获取, 本研究将依据病情轻重、治疗周期等进行亚组分析。此外, 采用敏感性分析检测 Meta 分析结果的稳定性, 若纳入研究不少于 10 项采用倒漏斗图分析潜在的发表偏倚。

2 结果

2.1 文献纳入情况

本研究共检索到 517 条题录, 其他来源补充文献 4 篇。通过查重排除 127 条题录, 对 394 条题录进行初筛, 初筛排除 365 条题录, 29 篇题录进入全文筛选, 因研究类型不符、干预不符等原因排除 23 篇

文献,最终纳入 6 项随机对照试验(Randomized Controlled Trial, RCT) 文献^[7-12]。涉及 451 例患者,其中男 269 例,女 182 例,年龄最大 65 岁,年龄最小 18 岁。文献筛选流程见图 1,纳入研究的基本特征见表 1。

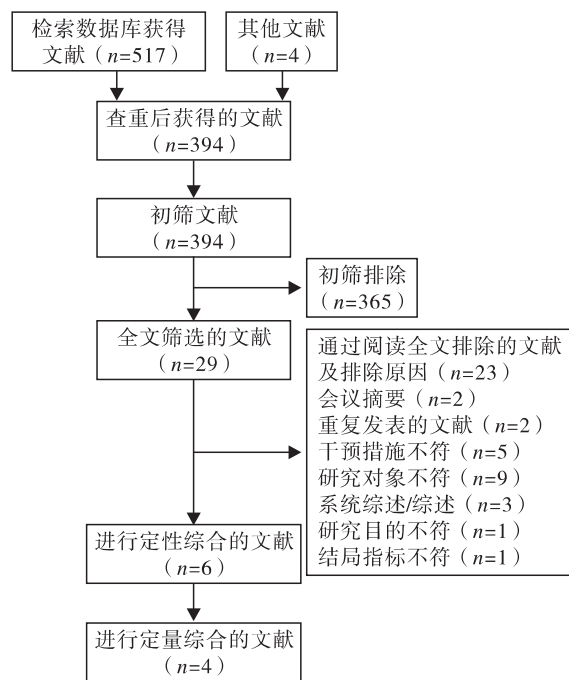


图 1 文献筛选流程图

2.2 纳入研究的文献方法学质量评价

共纳入 6 项^[7-12] 随机对照试验,如图 2 所示,其中 1 项研究^[9] 使用 SPSS 生成随机序列,1 项研究^[11] 使用随机数字表法生成随机序列,这 2 项研究

随机序列的生成被评为“低风险”;而其余 5 项研究的随机序列生成方式未知,被评为“偏倚风险不确定”。所有研究对随机序列分配时的隐藏均未报告,因此均被评为“偏倚风险不确定”。6 项研究干预措施多数不相同,且均未使用安慰剂,盲法似乎均不太可能实施,因此,所有文献的测量偏倚与实施偏倚被评为“高风险”。所有研究中,仅有 1 项研究^[9] 记录了脱落数据及脱落原因,其脱落数据 >20%,其不完整结局偏倚被评为“高风险”,其余各项研究的随机分组人数与进入统计分析人数一致,并且没有描述是否存在脱落病例,其不完整结局偏倚被评为“偏倚风险不确定”。所有研究均报告了临床重要结局,根据是否报告临床重要结局判断是否存在选择性报告偏倚,6 项选择性结果报告偏倚均被评为“低风险”。4 项研究^[7-9,12] 的试验组和对照组基线特征可比、纳排标准明确、无利益冲突,因此将这 4 项研究的其他偏倚评为“低风险”,其余研究因未提及基线可比性相关信息而被评价为“偏倚风险不确定”。

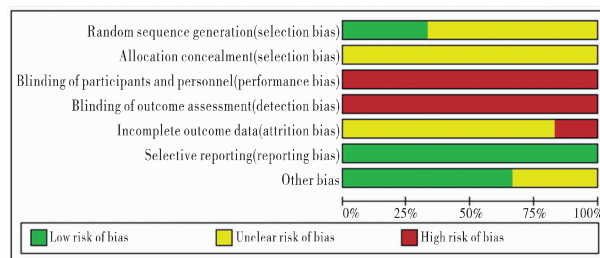


图 2 随机对照试验的偏倚风险评估

表 1 纳入随机对照试验的基本特征

纳入研究	诊断标准		干预组		对照组	
	HIV 感染/艾滋病诊断标准	抑郁诊断标准	男/女(例)	年龄(岁)	男/女(例)	年龄(岁)
侯明杰等 ^[7] 2019	《艾滋病诊疗指南》2011 版	《精神障碍诊断与统计手册》	33/21	43.70 ± 13.50	20/31	44.27 ± 10.56
舒云等 ^[8] 2016	《艾滋病和艾滋病病毒感染诊断标准》、《艾滋病诊疗指南》2015 版	《精神科量表评定手册》	15/15	23 ~ 52	15/15	22 ~ 54
培尔顿·米吉提等 ^[9] 2015	《艾滋病诊疗指南》2011 版	《中国精神疾病分类方案与诊断标准(CCMD-3)》	38/12	39.4 ± 8.9	31/19	40.75 ± 7.13
韦进新等 ^[10] 2018	《艾滋病指南》	-	16/12	36.1 ± 4.2	15/13	35.8 ± 4.6
闫炳远 ^[11] 2010	《艾滋病诊疗指南》2006 版	《中国精神疾病分类方案与诊断标准》	25/10	50.78 ± 14.64	24/11	49.86 ± 13.35
杨丽琴等 ^[12] 2013	2008 年中华人民共和国卫生行业标准——WS293-2008	《中国精神疾病分类方案与诊断标准(CCMD-2)》	19/11	19 ~ 60	18/12	18 ~ 59

表 2 纳入随机对照试验的基本特征

纳入研究	对照类型	干预组		对照组		疗程	结局指标
		样本量(例)	干预措施	样本量(例)	干预措施		
侯明杰等 ^[7] 2019	中医+常规治疗与常规治疗	54	柴胡加龙骨牡蛎汤+心理干预	51	心理干预	8 周	HAMD 抑郁量表
舒云等 ^[8] 2016	中医与常规治疗	30	温针灸+逍遥散加减治疗	30	帕罗西汀	15 d 为 1 个疗程,3 个疗程	HAMD 抑郁量表
培尔顿·米吉提等 ^[9] 2015	中医与空白	50	异常黑胆质成熟颗粒	50	无	4 周	HAMD 抑郁量表、生活质量(MOS-HIV)
韦进新等 ^[10] 2018	中医与常规治疗	28	温针灸+逍遥散加减	28	帕罗西汀	15 d 为 1 疗程,3 个疗程	HAMD 抑郁量表
闫炳远 ^[11] 2010	中医 I + 中医 II 与常规治疗 + 中医 II	35	逍遥散+益艾康胶囊	35	盐酸丁螺环酮+益艾康胶囊	6 周为 1 个疗程	HAMD 抑郁量表评分、生活质量积分(卡洛夫斯基积分)、不良事件
杨丽琴等 ^[12] 2013	中医+常规治疗与常规治疗	30	丹栀逍遥散+心理干预	30	心理干预	4 周	HAMD 抑郁量表评分

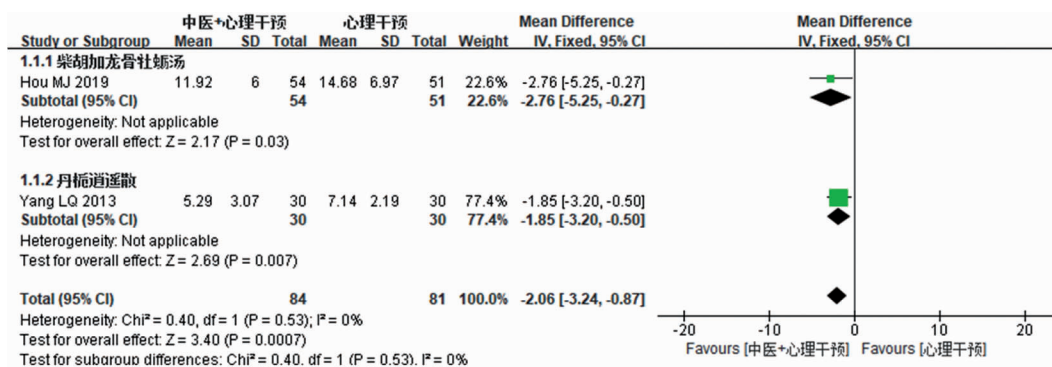


图3 HAMD 量表评分(中医 + 常规治疗与常规治疗)

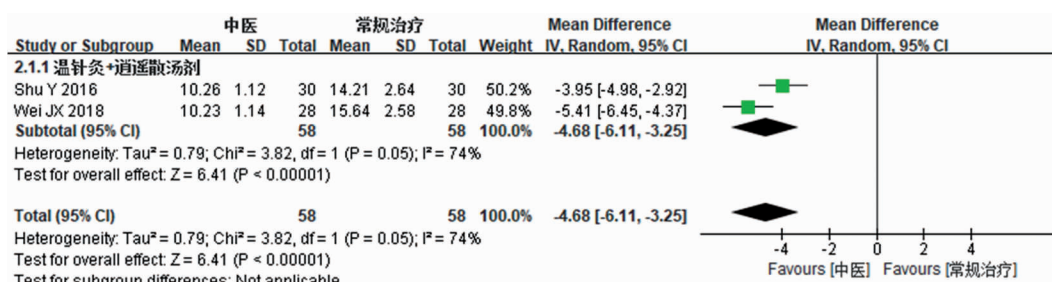


图4 HAMD 量表评分(中医与常规治疗)

2.3 效应指标分析

2.3.1 HAMD 量表评分

6 项研究^[7-12]报道了这一结局指标。

2.3.1.1 中药方剂联合常规疗法与常规疗法

有 2 项研究^[7,12]报道了这一结局,森林图见图 3,异质性检验: $\chi^2 = 0.40$, $df = 1$ ($P = 0.53$); $I^2 = 0\%$,采用固定效应模型。结果显示,中医联合心理干预较心理干预可能降低患者 HAMD 抑郁评分 [$MD = -2.06$, $95\% CI = (-3.24, -0.87)$; $Z = 3.4$, $P < 0.01$],证据质量为:低。柴胡加龙骨牡蛎汤联合心理干预较心理干预可能降低患者 HAMD 抑郁评分 [$MD = -2.76$, $95\% CI = (-5.25, -0.27)$; $Z = 2.17$, $P = 0.03$]。丹栀逍遥散联合心理干预较心理干预可能降低患者 HAMD 抑郁评分 [$MD = -1.85$, $95\% CI = (-3.20, -0.50)$; $Z = 2.69$, $P = 0.007$]。

2.3.1.2 中医药疗法与常规疗法

有 2 项研究^[8,10]报道了这一结局,森林图见图 4,异质性检验: $\tau^2 = 0.79$; $\chi^2 = 3.82$, $df = 1$ ($P = 0.05$); $I^2 = 74\%$,采用随机效应模型。结果显示,温针灸联合逍遥散较帕罗西汀可能降低患者 HAMD 抑郁评分 [$MD = -4.68$, $95\% CI = (-6.11, -3.25)$; $Z = 6.41$, $P < 0.001$],证据质量为:非常低。

2.3.1.3 中医与空白

有 1 项研究^[9]报道了这一结局,结果显示,异常黑胆质颗粒较空白干预可能降低患者 HAMD 抑

郁评分 [$MD = -3.76$, $95\% CI = (-5.54, -1.98)$; $Z = 4.13$, $P < 0.001$],证据质量为:非常低。

2.3.1.4 中药方剂 + 中成药与常规治疗 + 中成药

有 1 项研究^[11]报道了这一结局,结果显示益爱康胶囊联合逍遥散治疗较益爱康胶囊联合盐酸丁螺环酮治疗可能降低患者 HAMD 积分 [$MD = -1.71$, $95\% CI = (-3.03, -0.39)$; $Z = 2.53$, $P = 0.01$],证据质量为:低。

2.3.2 MOS-HIV 积分(中医与空白)

2.3.2.1 心理健康积分

有 1 项研究^[9]报道了这一结局指标,结果显示,异常黑胆质颗粒与空白干预在改善患者心理健康积分方面差异无统计学意义 [$MD = -2.32$, $95\% CI = (-6.11, 1.47)$; $Z = 1.2$, $P = 0.23$],证据质量为:非常低。

2.3.2.2 生活质量积分

有一项研究^[9]报告了这一结局指标,结果显示异常黑胆质颗粒与空白干预在改善患者生活质量积分方面没有统计学差异 [$MD = 2.96$, $95\% CI = (-0.89, 6.81)$; $Z = 1.51$, $P = 0.13$],证据质量为:非常低。

2.3.3 卡洛夫斯基积分(中医 1 + 中医 2 与常规治疗 + 中医 2)

有一项研究^[11]报道了这一结局指标,结果显示,益艾康胶囊联合逍遥散较益艾康胶囊联合盐酸

丁螺环酮可能提高患者卡洛夫斯基积分 [$MD = 7.02, 95\% CI = (4.57, 9.47); Z = 5.61, P < 0.001$], 证据质量为: 低。

2.3.4 不良事件

纳入研究中,有 1 项研究^[11]报道了这一结局指标。对照组患者服用药物后失眠 3 例,头晕 2 例,口干 1 例,但程度均较轻微,随着治疗时间的延长而减轻或逐渐消失。

3 讨论

古代中医文献中并无艾滋病一说,但大部分中医学集大成者根据其发病的临床表现,将其归属于中医学中的“疫病”“虚劳”等范畴。艾滋病在中医理论中的基本病机为正气不足,复感瘟邪淫毒,正虚无力抗邪,内外合因,严重损害全身脏腑功能。抑郁症属于中医学“郁证”范畴,主要是因为情志所伤,气机郁滞,脏腑功能失调所致。对于艾滋病抑郁症患者而言,抑郁症属于并发症之一,而抑郁症状又可能导致患者艾滋病的病情加重,因此对患者抑郁症状进行治疗是非常必要的。本研究系统综述所纳入研究中出现频次最多的单味中药为柴胡,柴胡具有引气上行,疏肝解郁的功效,可疏泄少阳而调肝脾。出现频次最高的中药方剂为逍遥散,逍遥散出自《太平惠民和剂局方》,方中柴胡可疏肝解郁,使肝气条达;当归养血活血,与白芍共用养血柔肝;白术、茯苓健脾利水,与甘草共用可理中益气,既能实土以御木侮,又能使营血生化有源;薄荷疏散郁遏之气,透达肝经郁热;生姜温胃和中,且能辛香达郁。诸药合用,可收肝脾并治,气血兼顾的效果^[13]。整体来看,本方肝脾同治,平其亢厉,气血津液兼顾,体用并调。所纳入文献中,出现较多的中医治法为温针灸,治法多用疏肝理气、健脾除湿、调和阴阳。随着针灸的不断发展,针刺治疗抑郁效果显著,有疗效好、疗效持久、复发率低等特点^[14]。从纳入研究中可见,在中医整体观念指导下,中医师多利用疏肝解郁、平肝潜阳、利水化湿等治法进行艾滋病抑郁的治疗,单纯使用中医治疗或中医联合西医治疗与单纯西医治疗相比,在改善患者抑郁状态、缓解患者焦虑情况、提高患者生存质量方面有着明显优势。

本研究的局限性主要有:证据质量低;存在基线特征、治疗方法、年龄、病程、病情及合并症等潜在的临床异质性因素;本研究纳入 6 项研究干预措

施大多不相同,且均未使用安慰剂,未能实施盲法,因此,本研究可能存在测量性偏倚和实施性偏倚;研究纳入的样本量不足。但因符合中医治疗艾滋病合并抑郁症的文章量较少,所纳入研究的干预均不一致,Meta 分析结果只能提示单纯中医或中医联合西医治疗对艾滋病联合抑郁患者的整体效果。由于纳入文献质量不高,所获得结论的可靠性较低。由于纳入试验数量较少,原计划的亚组分析、敏感性分析以及发表偏倚均无法进行。建议今后开展更多大样本、多中心、高质量的随机对照试验,为这一临床问题提供更加可靠的临床证据支持。

参考文献

- [1] BLANKSON J N, PERSAUD D, SILICIANO R F. The Challenge of viral reservoirs in HIV-1 infection [J]. Annual Review of Medicine, 2002, 53(1): 557-593.
- [2] UNAIDS. Global AIDS Update 2019—Communities at the Centre [M]. Geneva: UNAIDS, 2019.
- [3] ROTHENBERG R. The relevance of social epidemiology in HIV/AIDS and drug abuse research [J]. American Journal of Preventive Medicine, 2007, 32(suppl6): S147-S153.
- [4] RABKIN J G. HIV and depression: 2008 review and update [J]. Current HIV/AIDS Reports, 2008, 5(4): 163-71.
- [5] OLATUNJI B O, MIMIAGA M J, O'CLEIRIGH C, et al. Review of treatment studies of depression in HIV [J]. Topics in HIV Medicine A Publication of the International Aids Society USA, 2006, 14(3): 112-124.
- [6] HIGGINS J P, ALTMAN D G, GTZSCHE P C, et al. The Cochrane Collaboration's tool for assessing risk of bias in randomised trials [J]. BMJ, 2011, 343(2): 5928.
- [7] 侯明杰, 刘旭辉, 王延丽, 等. 中西医结合治疗艾滋病合并抑郁症 [J]. 中医学报, 2019, 34(6): 1275-1278.
- [8] 舒云, 蒋自强, 张雪. 针灸联合逍遥散加减治疗艾滋病抑郁症 30 例 [J]. 中医研究, 2016, 29(8): 68-70.
- [9] 培尔顿·米吉提, 热娜古丽·艾则孜, 努尔买买提·艾买提, 等. 维药异常黑胆质成熟颗粒对 HIV/AIDS 患者抑郁症状及生存质量的影响 [J]. 中医杂志, 2015, 56(11): 941-944.
- [10] 韦进新, 莫霞, 欧健, 等. 针灸联合逍遥散加减治疗艾滋病抑郁症的临床疗效 [J]. 医学新知杂志, 2018, 36(A1): 105-105.
- [11] 闫炳远. 益艾康胶囊合逍遥散加减治疗艾滋病伴发焦虑抑郁临床观察 [J]. 中国中西医结合杂志, 2010, 30(5): 553-555.
- [12] 杨丽琴, 邓鑫, 张亚萍. 丹栀逍遥散配合心理干预治疗艾滋病抑郁症 60 例临床观察 [J]. 大众科技, 2013, 15(6): 180-181, 132.
- [13] 邓中甲, 叶俏波, 刘舟. 邓中甲方剂学讲稿 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2011: 132-133.
- [14] 韩婷婷, 霍瑞雪, 张天琦. 艾滋病患者抑郁状况及其影响因素的述评 [J]. 中国当代医药, 2011, 18(23): 23-24.

(收稿日期: 2020-11-24)